PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO ESPORTE APLICADAS À SAÚDE

Avaliação pré-participação

Estrutura, anamnese dirigida e decisão

Medicina Esportiva Clínica

CASO ILUSTRATIVO

Marcou “não” porque não sabia que tinha

vinte anos parado → alta intensidade, na segunda semana → aperto no peito, na terceira série

Ficha de matrícula

Tem algum problema de saúde?

☐ sim ☑ não

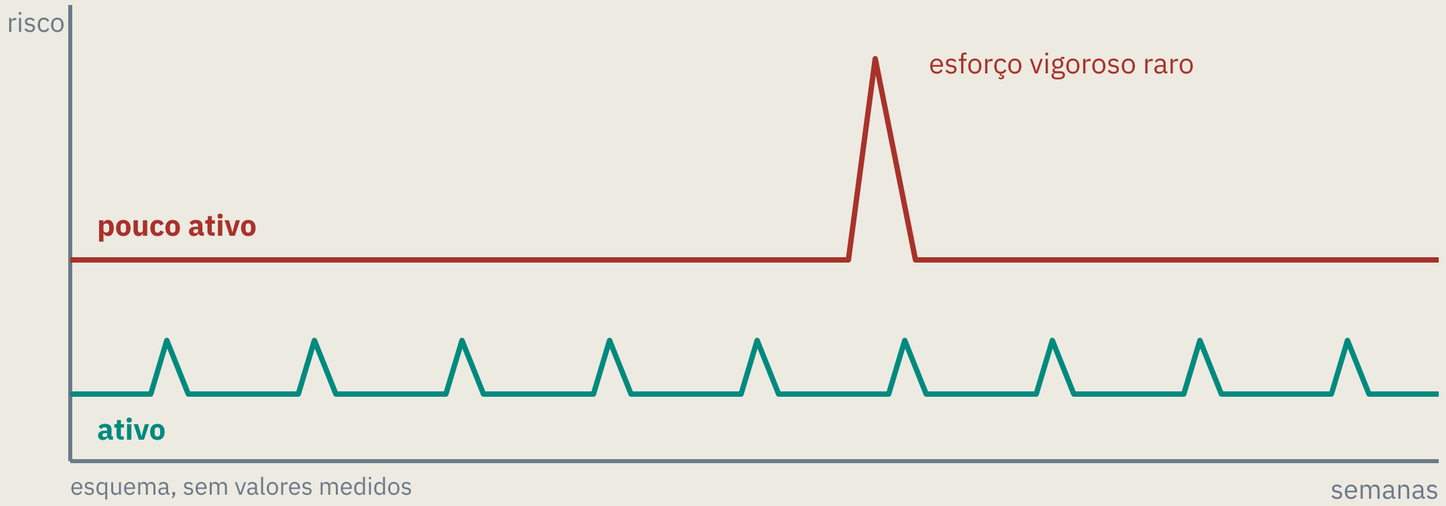
O que a investigação achou depois

- pressão alta sem tratamento
- colesterol nunca dosado
- trinta anos de cigarro
- circunferência abdominal alta
- pai morto de infarto aos cinquenta e poucos

Ninguém tinha perguntado.

ASSOCIAÇÃO AMERICANA DO CORAÇÃO, 2020

As duas frases são verdade



No esforço

o risco sobe, de forma transitória, e mais em quem é menos ativo

Na vida

o risco absoluto é pequeno; a atividade habitual reduz eventos; o saldo favorece a proteção

> A avaliação não serve para assustar nem para impedir. Serve para achar quem precisa de uma entrada diferente.

Franklin e colaboradores · Circulation 2020

COLÉGIO AMERICANO DE MEDICINA DO ESPORTE, 2015

Etapa um: três perguntas, não a idade

~~a idade~~

deixou de ser o critério

1

Já pratica exercício regular?

planejado, ao menos moderado, 30 min, 3 vezes por semana, nos últimos 3 meses

2

Tem doença ou sintoma?

cardiovascular, metabólica ou renal conhecida; ou sinais e sintomas sugestivos

3

Que intensidade pretende?

leve, moderada ou vigorosa

> O modelo anterior mandava gente demais ao médico. O rastreio cauteloso demais tira mais gente do exercício do que salva de evento.

Riebe e colaboradores · Medicine & Science in Sports & Exercise 2015

AS SAÍDAS DO MODELO

Quem precisa de liberação médica

	Sem doença, sem sintoma	Doença conhecida, sem sintoma	Sinal ou sintoma
Não pratica	**não precisa de liberação** começa leve a moderado e progride	**liberação recomendada** antes de começar	**liberação antes de começar** o sintoma é investigado primeiro
Já pratica	**não precisa de liberação** segue e progride	**moderado: segue** vigoroso: com liberação	**para e avalia** a única saída sem negociação

Perguntar sobre doença e sintoma é de todos. Investigar o que a pergunta achar é do médico. PAR-Q+: melhor que o formulário de uma linha.

Duas perguntas, uma entrevista com ordem

A: é seguro?
rastreio de risco: esta aula e a próxima

B: por que não adapta?
sono, energia, carga, medicação, substância

a ordem: do neutro para o íntimo

treino → sono → energia e comida → trabalho e vida → saúde e substâncias

> Quem abre perguntando o que a pessoa toma não tem anamnese; tem um formulário preenchido.

RENDEM MAIS DO QUE PARECEM

Três perguntas que quase ninguém faz

“O que mudou nos últimos seis meses?”

trabalho, sono, peso, medicação, vida

“Já parou alguma atividade por causa de um sintoma?”

acha quem se adaptou ao próprio limite: não diz que sente falta de ar, diz que parou de subir escada

“Toma alguma coisa por conta própria?”

estimulante, pré-treino, emagrecedor, anabolizante: ninguém relata sem ser perguntado

> Na primeira consulta, o que decide segurança: sintoma, doença, história familiar, medicação e substância. O resto melhora com vínculo.

Os sinais que interrompem tudo

Síncope durante o esforço

bandeira vermelha máxima

desmaiou no esforço: não treina até ser avaliado. Sem “foi só a pressão”.

Desconforto no peito no esforço

aperto, peso, queimação: quem nega “dor” descreve outra coisa

Falta de ar desproporcional

ou em repouso, ou ao deitar

Palpitação com tontura ou desmaio

isolada é comum; com sintoma, não

Queda de tolerância sem explicação

acima dos quarenta, a coronária se disfarça de “fora de forma”

Inchaço e falta de ar ao deitar

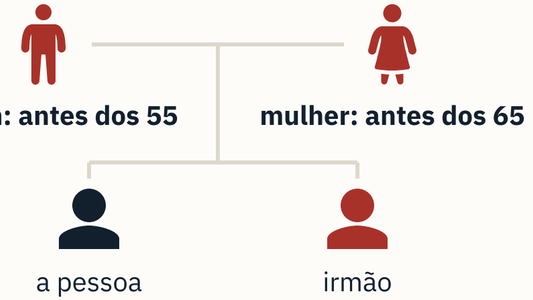
acordar sem ar: o conjunto da insuficiência cardíaca

Síncope logo depois de parar

costuma ser vasovagal; quem conclui é quem investigou

História familiar, fatores de risco, substâncias

História familiar



coronária precoce em parente de primeiro grau; morte súbita ou cardiopatia hereditária em qualquer idade

Fatores de risco

- pressão alta
- diabetes
- colesterol
- tabagismo
- obesidade abdominal
- doença renal

Medicações e substâncias

inclusive as de conta própria

> “Não sei” é resposta clínica: não é “não”, é motivo para medir a pressão ali mesmo.

O que fazer com o que se achou

Perfil	O que decide	Entrada
Jovem sem sintoma	sem história familiar	leve a moderado sem liberação; progressão
Meia-idade voltando	fatores de risco, sintoma, intensidade	conta do risco pelo médico; entrada gradual
Doença crônica compensada	quem prescreve e como monitora	exercício é tratamento, com critério
Atleta federado	exigência da federação ou do evento	outro sistema, outra lógica

> Doença cardiovascular estabelecida não é, em geral, contraindicação ao exercício. É indicação de exercício prescrito com critério.

QUASE NUNCA É TUDO OU NADA

Três saídas



O REGISTRO

O que não está escrito não aconteceu

Em uma página

- [x] as três perguntas do modelo
- [x] sintomas, com o que foi negado
- [x] história familiar, com idade e evento
- [x] fatores de risco, medicações, substâncias
- [x] conduta, data e orientação dada

Dois erros

✕ **“Sem alterações”**
sem dizer o que se perguntou

✕ **Nada sobre a recusa**
nem sobre a orientação dada

> O formulário de matrícula de uma linha é documento de defesa, não instrumento clínico. Trocá-lo custa cinco minutos por aluno.

TRÊS PERGUNTAS TERIAM BASTADO

A avaliação serve para permitir com segurança

- O critério não é a idade: o que faz, tem, sente e pretende fazer
- Síncope durante o esforço interrompe tudo até ser avaliada
- Escreva o que perguntou, o que foi negado e o que orientou

Médico

Libera, investiga, diagnostica, trata.

Educador físico e preparador

Progride a carga; reconhece o sintoma no treino.

Fisioterapeuta e nutricionista

Fazem as mesmas perguntas, com frequência.

Perguntar é da sua profissão, qualquer que seja ela.